

膀胱镜检查

患者须知 · 观察您的尿道和膀胱内部

WARWIKI

膀胱镜检查是医生用一根细小的内镜（带有微型摄像头和光源）经自然尿道口轻柔插入，直接观察您的尿道和膀胱内部。此检查有助于查明血尿、反复感染、管腔狭窄或其他膀胱问题的原因，也可用于术后复查。

关于这项检查

膀胱镜（cystoscope）是一根末端带有摄像头的细管，分为两种：

- **软镜（可弯曲）**：通常在门诊清醒状态下使用，操作前会在尿道内注入麻醉凝胶（numbing gel）。
- **硬镜（直型）**：在手术室全麻下使用，医生可在同次检查中同时处理问题。

检查时会注入无菌生理盐水，轻柔扩张膀胱，使膀胱壁清晰可见。医生可能因以下原因安排膀胱镜检查：

- 查明**血尿**或反复感染的原因
- 寻找**狭窄**、结石或新生物
- 评估术后愈合情况，或取少量组织（活检）
- 放置、检查或取出**支架**或缝线

安全吗？

安全。膀胱镜检查是泌尿外科最常见的检查之一，风险很低。大多数人只有短暂不适。偶见轻微副作用——尿路感染、少量出血或短暂烧灼感、排尿困难——通常程度轻微、自行消退。

名词解释

膀胱镜（Cystoscope）

带有摄像头和光源的细内镜，用于观察膀胱内部。

膀胱（Bladder）

储存尿液的肌性囊腔，排尿时收缩。

尿道（Urethra）

将尿液从膀胱导出体外的管道。

软镜与硬镜

软镜（可弯曲）在门诊清醒下使用；硬镜（直型）在手术室麻醉下使用。

麻醉凝胶（Numbing gel）

注入尿道的局部麻醉药，使内镜通过时更舒适。

活检（Biopsy）

取少量组织在显微镜下检查。

支架（Stent）

保持管腔通畅的软管，可在检查时置入或取出。

排尿后残余尿

排尿后膀胱内剩余的尿液量。

会疼吗？ 软镜检查时，内镜通过尿道可能有短暂压迫感或刺痛感——麻醉凝胶有助于减轻不适，门诊检查通常几分钟内即可完成。硬镜检查在麻醉下进行，检查过程中您不会有任何感觉。如有不适，请随时告知医疗团队。

如何准备（检查前）

- 门诊软镜检查前通常可以正常饮食、服药，检查后可自行驾车回家。
- 麻醉下的膀胱镜检查，请遵照手术须知——禁食、哪些药物需暂停，并安排他人接送。
- 医生可能要求您提供尿液样本以排查感染，并可能预防性使用抗生素。

如有以下情况，请提前告知医疗团队：

- 正在服用抗凝药
- 有尿路感染症状（尿痛、发热，或尿液浑浊、气味浓烈）——活动性感染可能需要推迟检查
- 有药物过敏史，或曾因尿道狭窄导致内镜难以通过

过程

- 1 您平躺舒适，医疗团队协助您摆好体位，对尿道口进行清洁并注入麻醉凝胶。
- 2 膀胱镜经尿道轻柔插入膀胱。
- 3 注入无菌生理盐水扩张膀胱，医生全面检视膀胱内壁。
- 4 检查结束后取出内镜。如需同时进行治疗、活检或更换支架，将在取镜前完成。

之后

- 门诊检查后通常可立即恢复正常活动；麻醉下检查后需休息并安排他人接送。
- 排尿时可能有轻微烧灼感，持续约一天。多饮水有助于冲洗尿道、缓解症状。
- 尿液中可能出现淡红色，属于常见现象，通常一天内消退。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或畏寒
- 排尿困难或完全无法排尿
- 大量出血，或尿液中出现血块
- 疼痛持续加重而非减轻

需要记住的三件事

1. 膀胱镜检查是用细小摄像头快速、安全地观察膀胱和尿道内部，帮助医生发现问题或评估术后恢复。
2. 门诊检查几乎无需特殊准备。麻醉下检查需遵守禁食要求并安排接送，同时告知医生是否服用抗凝药或有感染症状。
3. 轻微烧灼感或尿液淡红持续约一天属正常现象——多饮水；若出现发热、大量出血或排尿困难，请及时就医。